



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اعتماد السمان احمد عبد الحافظ

العنوان : 0

الحي / المدينة : عين شمس

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

رقم التليفون : 01145407839

رقم البطاقة : 24408192600642

العمر (تاريخ الميلاد) : 19-08-1944 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اعتماد السمان احمد عبد الحافظ National ID: 24408192600642	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

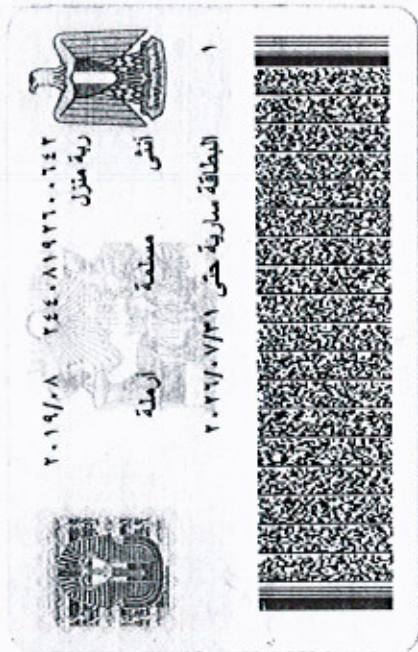
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Patient Name: Eatemad Al Samman Ahmed Al Hafez	Date: 28/10/2025
Exam: CT CAP(CT Chest Abd. Pelvis)	Age: 81 Year(s)
Medical ID: 1119/2023	Pat. ID: 29386

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction.

FINDINGS:

Compared to the last study dated 11-5-2025 ,the current study revealed:

(I) Chest: *Showing complete resolution of the previously noted pulmonary nodules.*
▪ Still noted scattered bilateral lower lobar and left upper lobar posterior segmental patchy areas of ground glass attenuation are noted.

▪ ~~Complete resolution of the previously noted pulmonary nodules.~~

- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- Cardiomegaly.
- Large left breast mass lesion , measuring 66x58 mm in diameter with left axillary pathological lymphadenopathies, reaching 34x22 mm ,for sonomammographic correlation.
- Markedly enlarged thyroid gland with substernal extension and heterogeneous texture,for sonographic assessment.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions on non-contrast base.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Aortoiliac extensive atheromatous calcifications are noted.

- Bulky uterus ,for sonographic assessment.
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Advanced dorsolumbar spondylotic changes.

OPINION:

- Follow up status showing the above detailed changes. *deriving*
involved stony course vital

Dr.Sara Mahmoud, MD

Dr.Sara Ali

Dr.Sara Ali

(Stationary or Regressive)

[Signature]

Name: Pitmad Al-Samman Ahmed Abdel Hafiz
Branch: Dokki
Ref Physician Prof: Gosta Rosch Hospital

Date: 27-10-2025 12:09
Medical No.: 235041
Ins. Company: تعاقد مستشفيات

Tc^{99m} MDPSKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- An 81-year-old lady, with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Marked degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name: أحمد السيد محمد

Sex:

MDT form

3- Medical number:
Female

83133995

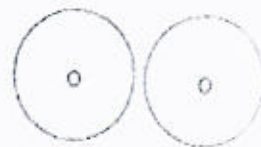
Old Med:

Old Med:

1119/2023

2-ID number: 24408192600642

Patient Age: 80 Y



Family history

Family history

Phone

Phone

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Co morbidity

Co Morbidity

HTN, CKD

Menopausal
status

Menopausal Status
POST MENOPAUSE

Initial STAGE

Initial STAGE

2025-06-10

Breast Imaging :

Clinical data

Mets Workup :

CT-->MULTIPLE VERTEBRAL +STERNAL OSSEOUS LYTIC
LESION FOR BONE SCAN, MULTIPLE THYROID NODULES

BX

IDC

OK COMMENT

ER

8/8

OK COMMENT

PR

8/8

OK COMMENT

Her 2 Neu

2

Her 2 Neu COMMENT

SISH

Not Amplified

SISH COMMENT

Ki67

40

T

3

N

1

M

1 (BONE)

Sonomammography

LT BREAST MULTICENTERIC MALIGNANT MASS LESION AT 7 O'CLOCK+ MICROCALCIFICATION
BIL NON SPECIFIC AXLN

PATIENT HISTORY

received AI for 15 months -->PD of lt breast & axillary LN
aromasine for 6 months -->SD bone , PD breast mass

MDT OUTCOME & PLAN

HOT OUTCOME & PLAN

FOR FASOLDEX - IBRANCE
ZOMETA Q 3 MONTH

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

SURGERY

Psychiatric

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

MDT Form MDT Form

[[DOCTYPIEMDTFORM]] FORM]]

Patient Name :	الاستاذة / اعتماد السبعان احمد	Request No. :	13006835
Patient No. :	24408192600642	Request Date :	04/03/2023
Path No. :	659/2023	Verification Date :	26/03/2023
Sex :	Female	Financial Category :	مبادرة السلام - مبادرات
Age :	78 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc. :		IHC No. :	
		Registered by :	marwa monem

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA

left breast mass

NATURE OF SPECIMEN

tru cut biopsy

GROSS EXAMINATION

Three cores of soft tissue, the longest one 1cm, all submitted .

MICROSCOPIC EXAMINATION

Histological type: Invasive duct carcinoma .

Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+3+2) Grade III

DCIS: No

Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :

ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)

HER2: Intermediate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)

SISH: Not amplified

average Her2 copy No. : 3.2 , Her2/CEP17 ratio : 1.6)

Ki 67: 40 % nuclear reaction of tumor cells

DIAGNOSIS

left breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :

invasive duct carcinoma, Grade III .

Verified by :

Name : I'timad Al-Samman Ahmed Abd El Hafiz Date : 11-09-2026 06:23
Branch : Dokki Medical No. : 459191
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt Ins.Company : تعافى مستشفى

N
I
L
E
D
I
A
G
N
O
S
T
I
C
F
E
N
C
E
R

Tc-99m MDP follow up SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

82 year-old female patient with history of treated left breast cancer, complains of bone pain and referred for follow up.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- Considering the last bone scan report dated 27/10/2025, the current scan revealed the same scintigraphic features with no evidences of osseous tracer uptake abnormalities that would account for bone secondaries.
- Degenerative features are depicted at different levels of the spine with dorso-lumbar scoliosis.
- Osteoarthritic features are noticed around big joints.

IMPRESSION:-

- The skeleton is keeping free from osseous metastasis.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine